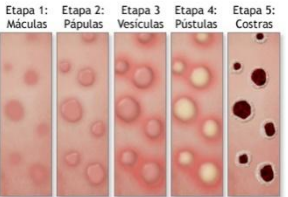
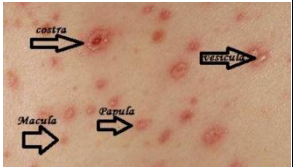


	Sarampión	Rubeola	Varicela	Exantema súbito (Roséola)	Escarlatina
Agente etiológico	Virus del sarampión (Paramyxoviridae, Morbillivirus)	Virus de la rubeola (Rubivirus, Togaviridae)	Virus varicela zoster (herpesvirus)	HHV-6 (más común) HHV-7 (menos común y más mortal)	Streptococcus pyogenes
Periodo de incubación	7 a 21 días (promedio 14 días)	12 a 33 días (promedio 18 días)	10 a 20 días (promedio 14 días)	7 a 21 días	2 a 7 días
Periodo de transmisibilidad	4 días antes y 4 días después de la aparición del exantema	5 a 7 días antes y 4 a 7 días después de la aparición del exantema	2 días antes de la aparición del exantema hasta la fase de costras de las lesiones	10 días antes y 7 días después de que inicie el exantema	Origen respiratorio: 10 a 21 días. Origen cutáneo: varias semanas. Con tratamiento: 48 horas.
Viremia	1ra: 2 a 3 días 2da: 4 a 7 días	5 a 7 días			
Etiología	Fines de invierno e inicio de primavera	Final de invierno y primavera	Invierno e inicio de primavera	Distribución mundial sin predominio estacional.	Primavera y verano
Cuadro clínico	Pródromo: Tos seca (última en desaparecer) Fiebre 40° (3 a 4 días, aumenta con rapidez) Malestar general Conjuntivitis intensa, supurativa, bilateral, línea marginal de	Pródromo (1 a 5 días): Cefalea Fiebre <39° Malestar general Irritación de las conjuntivas 5 a 10 días antes del exantema:	Pródromo (1 a 2 días): Febrícula Malestar general Inicio:	Fiebre >40° (5 días)	Fiebre alta <39.5° Malestar general Faringoamigdalitis (supurativa) Lesión: Eritema generalizado y pápulas puntiformes (aspecto de lija)

	inyección conjuntival en parpado inf  Lagrimeo Fotofobia Cefalea Rinorrea Diarrea (a veces) 2 días después: Eritema intenso en el velo del paladar Signo de Koplik Cuarto día:  Exantema morbiliforme, primero macular y después papular. 	Adenopatía dolorosa cervical, suboccipital y posauricular Erupción cutánea (3 a 4 días, en el orden que aparece): Manchas eritematosas pálidas y papulas confluentes, de progresión cefalocaudal,  cara→cuello→tronco→extremidades→nalgas Manchas de Forchheimer (6 a 10 días) 	Exantema maculopapular leve 4 a 5 días después: Erupción vesicular en el tronco, cara, piel cabelluda y raíces de  las extremidades (distribución centrípeta) Vesículas aisladas sobre base eritematosa (gota de rocío sobre pétalo de rosa) →pústulas 2 a 3 días después: Costras que al desprenderse forman depresiones Las lesiones tienen diferentes etapas evolutivas Pruriginosas	Al normalizarse la temperatura, aparece súbitamente el exantema maculopapular, inicia en el cuello a la periferia, de distribución cefalocaudal Congestión de  faringe, amígdalas y membranas timpánicas  Malestar general Convulsiones febriles 10% Convulsión clónica única y simple, con una duración menor de 5 min y se presenta solo una vez en 24 horas Manchas de Nagayama (enanema	Respetar la región prioral (triángulo de Filatov), palmas y  manos Signo de Pastia: Líneas eritematosas en región antecubital  por fragilidad capilar
--	---	---	---	---	---

	Comienza en la zona retroauricular→ línea de implantación de cabello→frente→región mastoidea→parte alta de cuello→   parte proximal de extremidades→tronco →manos y pies (distribución cefalocaudal) →confluentes  Prurito (raro)	Síntomas articulares (corta duración)	Afecta mucosa, conjuntivas, oral y vulvar 	en paladar blando y úvula) Adenopatía retroauricular más pequeña a comparación de rubeola	Primeros 3 días de la erupción: Lengua se hace saburral, y las papilas linguales son hipertroficadas  Se limpia la saburra y  queda la lengua en fresa Manchas de Forscheimer
--	---	--	---	--	--

	Sexto y décimo día: Inicio de involución en la cara: Descamación fina y pigmentación				Después de 1 a 2 semanas: Descamación fina abundante en cara y tronco  Descamación en laminas en manos y pies 
Complicaciones	<2 años: Neumonía Laringotraqueobronquitis CRUP (disfonía, tos traqueal, estridor) Otitis media Niños desnutrición y def de VitA: Diarrea Crisis convulsiva por fiebre Cicatrices corneales con ceguera	Encefalitis posinfecciosa Manifestaciones hemorrágicas Sx de Guillain-Barré Miocarditis Pericarditis Anemia hemolítica Purpura trombocitopénica Hepatitis	Desnutridos e inmunocomprometidos: Fiebre alta	Encefalitis Otitis media Convulsiones febriles	Complicaciones tempranas: Linfadenitis cervical Otitis media Absceso periamigdalino Sinusitis Bronconeumonía Meningitis Absceso cerebral Trombosis del seno venoso intracraneal Septicemia Hepatitis

	Encefalitis aguda Paraencefalitis esclerosante Kwashiorkor agudo Embarazadas: Aborto Parto prematuro		Ampollas grandes, hemorragias o necróticas  Niños sanos (raro): Cicatrices deprimidas Infecciones cutáneas estreptocócicas o estafilocócicas Fascitis Purpura trombocitopénica Pleuritis Neumonía Encefalitis Septicemia Síndrome de Reye		Vasculitis Uveítis Miocarditis Choque toxico Complicaciones tardías: Fiebre reumática (Importancia) Glomerulonefritis postestreptocócica Líneas de Beau Efluvio telógeno
Tratamiento	No tx antiviral Suplementos de vitamina A (reducen mortalidad 50%) Niños con deficiencia de vitamina A: 2 dosis con intervalo de 24 hrs	Medidas sintomáticas Aislamiento respiratorio (7 días a partir del exantema)	Polvos secantes: Talco Óxido de cinc Almidón Baños de avena y con poco jabón Antihistamínico o acetaminofén	Paracetamol 15 mg/kg cada 6 horas o 10 mg/kg cada 4 horas. Baños de esponja Vitamina A	Penicilina V (fenoximetilpenicilina) o amoxicilina VO por 10 días Penicilina G benzatínica IM dosis única

	Menores de 6 meses: Dosis de 50,000 UI 6 a 11 meses: 100,000 UI >12 meses: 200,000 UI Hidratación oral Antipirético (acetaminofeno) Terapia nutricional Reposo		Px mal estado o alteraciones inmunitarias: Antivirales o gammaglobulinas, IM, cada 5 días Varicela neonatal: Aciclovir 5 a 10 mg/Kg/día cada 8 hrs por 5 días Niños 2 a 13 años (sin TxInm): Aciclovir 20 mg/Kg, 4 veces al día por 5 días (<800mg) Adultos: Aciclovir 800 mg, 5 veces por día, por 7 a 10 días Valaciclovir 1000 mg, 2 veces al día, por 5 días		Niños alérgicos a penicilina: Cefalosporinas (cefalexina o cefadroxilo) /clindamicinas/claritromicinas, por 10 días Azitromicina VO por 5 días
Vacuna	SRP 2 dosis Vía subcutánea, región deltoides o tricipital del brazo izquierdo 1ra: 12 meses 2da: 6 años o ingreso a primaria		SRPV 2 dosis Intervalo entre 4 semanas a 3 meses Se aplica de los 4-6 años	No hay, son los papás	